

中低收入國家 ICU 肺炎的預後

系統性回顧與統合分析

Outcomes of Pneumonia in ICUs in Low- and Middle-Income Countries

讀書會共筆整理 | 謝慕揚 MD, PhD, FESC · 2026-06-04

原文：[NEJM Evidence 2026 \(DOI 10.1056/EVIDoa2500244\)](https://doi.org/10.1056/EVIDoa2500244)

一句話總結

- 統合 52 篇 / 18 國 / 48,707 名 CAP 入住 ICU 病人
- 整體死亡率 37% (95% CI 31–42) ; 機械通氣者 61% (44–75)
- 年齡 + 機械通氣 = 最強調節因子 (解釋 55.2% 異質性)
- 無低收入國家資料 → 巨大缺口

背景

- CAP 是 LMICs ICU 住院與死亡主因之一
- 過去預後資料多來自高收入國家
- 問題：LMICs ICU 肺炎真實死亡率與調節因子為何？

方法

- 系統性回顧 + 統合分析 (PROSPERO CRD42022363048)
- 納入觀察性研究 + 臨床試驗 ; CAP 入住 ICU、於 LMICs
- 主要結果 : **全因 ICU / 28 天 / 30 天死亡率**

主要結果

項目	數值
研究 / 國家 / 病人	52 / 18 / 48,707
來源	多為中高收入；無低收入國家
常見共病	高血壓、COPD、糖尿病
機械通氣使用	中位 59% (IQR 41–77)
整體死亡率	37% (31–42)
機械通氣者死亡率	61% (44–75)

死亡率約為高收入國家數倍；上呼吸器者預後尤差。

解讀與限制

- 高死亡率反映疾病嚴重度 + **資源落差**（呼吸器、人力、抗生素可近性）
- **限制**：
 - 異質性高（國家/年代/收治門檻）
 - 觀察性、發表偏倚、來源集中中高收入國
 - **無低收入國家資料** → 無法外推至最弱勢地區

Take-home

1. LMICs ICU CAP 死亡率 ~37%，機械通氣 ~61%。
2. 年齡 + 機械通氣主導死亡率。
3. 低收入國家零資料是最大缺口——重症照護的健康不平等。

謝謝聆聽

Q & A

讀書會共筆整理 | 謝慕揚 MD, PhD, FESC

原文 : *NEJM Evidence 2026 · DOI 10.1056/EVIDoa2500244 · PMID 42189048*